EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 72864
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2023-10-23 09:09:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: BARBARA NICOL ACU◆A SEPULVEDA			RUN	: 18.379.705-0
F.Nac	: 14-11-1993	Edad	: 29 AÑOS, 11 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: BUCALEMU			Comuna	: NIQUEN
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 986777207		
Fecha Ingreso	: 2023-09-13	Fecha Egreso	: 2023-10-23 09:09:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. A87.8-OTRAS MENINGITIS VIRALES

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

- Hipodensidad hemisférica izquierda y cerebelosa derecha. Obs Stroke-like
- Mitocondriopatía mutación m.827 A>G
- Status epiléptico resuelto.
- ITU, obs alta. E coli multisensible 5/7
- Conjuntivitis bacteriana izquierda
- Sd febril. Flebitis ESI. CSB SAMS, HC 1 de 2 S epidermidis. Tratada
- Antecedentes: Anacusia, epilepsia.

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. A87.9-MENINGITIS VIRAL, SIN OTRA ESPECIFICACION (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Antecedentes:
- Epilepsia
- Sordomuda desde nacimiento.

Antecedentes quirúrgicos:
- Cesarea y esterilización tubaria

Antecedentes familiares:
- Hermana biológica sordomuda y epilepsia infantil. Fallecida el 09/09/23 a los 34 años. Status convulsivo, hospitalización 1 mes en Hospital de Rancahua. Fallece por intercurrencia infecciosa.
- Hijo de 11 años, sin patologías.
- Padre biológico sano. Madre biológica sana.

Alergias:
- Sin antecedentes de alergia a medicamentos

Antecedentes GO:
- G1P1A0
- FUR 07/09/23
- MAC: esterilizada

Medicamentos:
- Levetiracetam 500 mg cada 12 horas
- Ac Valproico 200 mg cada 8 horas

Hábitos:
- Tabaco (-)
- OH (-)
- Drogas (-)

Social:
- Bucalemu, 986777207

Diestro mRS 2
Padres sanos, hermana biológica con epilepsia y sordomuda. Se desconoce si fue al nacer o en años posteriores.
Diagnóstico de epilepsia en 2020, se inicio tratamiento con Levetiracetam 500 mg cada 12 horas. tendría en ese entonces EEG informe en Parral EEG anormal con desorganización de los ritmos de base y fenómenos paroxísticos frecuentes.
En 2021 con episodio de crisis en relación a fiebre secundaria a infección respiratoria, se agrego e extrasistema Ac Valproico 200 mg cada 8 horas. En ultimo años sin cambios de funcionalidad importantes, pero mas olvidos que antes.
Fallecimiento de hermana sábado 09/09/23 acude a funeral, refiere cefalea escasa. El lunes 11/09/23 encontrada en la mañana por cuidadora, con menor actividad, con debilidad generalizada, sin comunicación con hermana se coordina hora para el 12/09/23 siendo derivada a SU de HSC para evaluación.
Derivada desde consulta neurológo por compromiso de conciencia y aumento de número de crisis. Ingresa a SU de HSC febril hasta 39°C, sin compromiso hemodinámico (PA 125/85 mmHg), Sat 98%, HGT 87 mg/dL. Al examen se describe con compromiso de conciencia, en sopor superficial-medio, hipertonia.
Se solicitó estudio complementario en que destaca leucocitosis leve de predominio mononuclear, y PCR en 30. TC de encéfalo con disminucion de volumen encefálico y ventriculomegalia pasiva. Se compara con TC del 2021 en que se constata progresión de atrofia.
Se trata como caso sospechoso de meningitis infecciosa, se aisla, se inicio tratamiento antimicrobiano y se ingresó a UTI. Durante la noche disminución progresiva de fiebre, sin eventos sospechosos de crisis.
Se toma conocimiento formal del caso el 13/09/23 paciente en regulares condiciones generales, afebril, hemodinamia estable. Sin apremio ventilatorio. En cuanto a lo neurológico con mejor nivel de conciencia, se conecta con evaluador.

Evolución durante hospitalización.
Neurológico:
Posterior a ingreso se reciben resultado de estudio infeccioso con panel meningitis encefalitis negativo y cultivo negativo. Se decide suspender aporte de antimicrobianos.
Cursa con patrón de status convulsivo aumentando en forma progresiva el numero y dosis de FAE. Sin embargo con progresión estacionaria. En estudio con RM de encéfalo se constata restricción de DWI en forma difusa hemisférica izquierda sin claro patrón vascular. Considerando como etiologías encefalitis autoinmunes por lo que se realizaron 5 pulsos de MTP de 1 gramo, se solicitó estudio antiMOG el que se gestionó por HSC y a la fecha aun en adquisición. Sin respuesta satisfactoria.
Se considera por imagen, antecedente de hermana y deterioro con aumento de VPA, sospecha de mitocondriopatía basal, por lo que se suspende aporte de VPA, y se inició restitución de L-Arginina y CoQ10 con regresión del numero de crisis y mejoría en progresiva de funcionalidad.
Se recibe estudio de mitocondriopatías costeado por familiar, en que se constata mutación m.827 A>G, sin presencia de 4 mutaciones mas frecuentes de MELAS estudiadas. Se discute caso con genética y se considera posible presencia de mitocondriopatía menos frecuente que con uso crónico de VPA se habría gatillado stroke like.
En cuanto a la rehabilitación, logra marcha con asistencia y en lo deglutorio estacionaria por lo que se instala GTT con plan de eventual retiro en meses siguientes.

Infeccioso.
Cursó con bacteriemia por S epidermidis que se trata por 10 días, con parámetros inflamatorios bajos.
Posteriormente con ITU baja por E coli multisensible que se encuentra en tratamiento al momento de alta.
CUrsó con conjuntivitis bacteriana con cultivo del 17/10/23 negativo, en tratamiento al momento del alta y con evolución favorable.
Considerando control de crisis adecuada, mejoría progresiva de funcionalidad, sin intercurrencias infeccisoas mayores actuales, se plantea alta hospitalaria para seguimiento posterior en forma ambulatoria.

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo. Levantar asistida en forma diaria. Pasar a sillón.
2. Diben 1,5, 350cc por 3 veces + agua 300cc por 4 veces
3. L-arginina 5000 mg por día. 5 comprimidos disolver en agua por GTT
4. Coenzima Q10 100 mg por día, extraer contenido de 10 grageas, disolver con aceite y administrar con jeringa GTT
5. Neurobionta advance, 1 comp al día, GTT.

6. Levetiracetam 500 mg, 3 comp cada 12 horas, GTT.
7. Fenitoina 100 mg, 3 comp cada 12 horas, GTT.
8. Lacosamida 50 mg, 2 comp cada 12 horas, GTT.
9. Clobazam 10 mg, 2 comp cada 12 horas, GTT.
10. Cefadroxilo 500 mg, 2 caps cada 12 horas, GTT x 5 días
11. Prednisona 5 mg, cada 48 horas durante una semana y posteriormente suspender.
12. Elcal-D, 1 comp al día, por GTT por una semana y posteriormente suspender.
13. Cotrimoxazol Forte, 1 comp lunes-miercoles-viernes por 1 semana y suspender.
14. Famotidina 40 mg, 1 comp al día, por GTT
15. Moxifloxacino 0,5% 1 gota cada 4 horas posterior a aseo ocular
16. Prednisolona 1%, 1 gota cada 4 horasposterior aseo ocular
17. Parche ocular nocturno.
18. Kinesioterapia motora
19. Fonoaudiología rehabilitación deglución
20. Control en CAE de neurología HSC posterior a alta.
21. Control en servicio de urgencias en caso de necesidad. Se explican situaciones de reconsulta.

EXÁMENES Y RESULTADOS

- 23/10/23 Creat 0.3, MDRD 206, Uremia 11, ELP 140/4.2/105, Hb 13, Hto 38.2, Leuco 6000, plaq 205.000, PCR 27.6. Procalc 0.04.
- 03/10/23 Glic 126, Creat 0.4, MDRD 188, Uremia 18, BUN 7, ELP 139/3.7/103, Hb 11.5, Hto 33.4, leuco 6800, Plaq 183.000, VHS 5. PCR 49.7. Alb 3.4. INR 1.09. NP PHT 6.4 corregido 9
- 29/09/23 Glic 108, Creat 0.4, MDRD 188, Uremia 24, BUN 11, ELP 136/3.5/100, Hb 11.7, Hto 34.6, Leuco 10300, Plaq 205.000, VHS 10, PCR 51.7
- 27/09/23 NP PHT 19.7
- 26/09/23 Glic 124, Alb 3.5, Creat 0.5, MDRD 145, Uremia 27, ELP 135/3.8/102, Hb 12.2, Hto 35.6, Leuco 10700, plaq 265.000, VHS 6, PCR 24.2 lactato 1.1. NP fenitoina corregido 5.
- 25/09/23 Alb 3.6, Creat 0.5, MDRD 145, Uremia 30, ELP 140/3.7/102, Mg 2.1, Amonio 26, Hb 12.2, hto 36.7, leuco 13300 (84%), PLaq 273.000, VHS 2, Procalc 0.03, PCR 24.5, P hepático normal.
- 22/09/23 EEG st: al inicio del registro de crisis, ritmo posterior lentitud rítmica y desorganización. Descargas punta y polipunta frontotemporal derecha.
- 21/09/23 NP PHT 11.7, corregido por alb 15
- 20/09/23 Glic 104, Uremia 34, BUN 16, ELP 138/3.9/104. Hb 11.7, hto 35.5, leuco 13400, Plaq 230.000. VHS 3. Procalc 0.03. HC 1 S epidermidis multiS. HC 2 pendiente. CSB SAMS
- 17/09/23 Alb 3.0, Creat 0.4, Uremia 17, ELP 136/3.7/104, Ca+2 7.6 (8.4), PCR 30, C3 90, C4 12.6. Hto 36, Hb 12.0. ANA (-), ANCA (-), PTH normal, ENA 0.12
- 16/09/23 LCR prot 8.0 mg/dL (previo sobre 50), alb 1.4 mg/dL (17.7-25.1), Lactato 2.0, leuco 2, Gluc 48. Gram sin bacterias. GeneXpert negativo.
- 16/09/23 RM de encéfalo con contraste: disminución importante de parénquima. Con HiperT2/FLAIR en forma difusa en corteza bilateral con restricción DWI/ADC giral fronto, insulo-temporal y occipital izquierda que no sigue patrón vascular, sin ser informado en RM. Al uso de contraste con refuerzo meningeo.
- 15/09/23 Calciuria 6.0 mg/dL, 102.0 mg/dL 24 horas, Magnesuria 3.1 mg/dL (bajo), ELP urinario Na+ 121, K 17.4
- 14/09/23 VitD 17.8
- 13/09/23 Ca+2 7.9, Alb 4, P 3,4, Mg+2 2.0, VPA 28,1. TSH 0,689, T4L 0,58, procalc 0,05. RPR (-) VIH (-)
- 13/09/23 EEG st: técnicamente limitado por artefacto muscular, disfunción lenta generalizada, sin AE, sin patrón de crisis ni estado epiléptico
- 13/09/23 AngioTC de encefalo: no impresiona alteraciones vasculares de relevancia. Senos venosos permeables.
- 13/09/23 TC de tórax SC: dudoso infiltrado en lóbulo superior izquierdo
- 12/09/23 LCR prot 53, alb 18.3, Lactato 2.2, Leuco 0, Gluc 58, gram sin bacterias. Panel meninigitis encefalitis negativo, cultivo negativo.

OBSERVACIONES:

Al examen neurológico al alta:
- Mental: vigilia, apertura ocular espontanea, cierre palpebral forzado, se conecta con evaluador, sigue con la mirada. Sonrie
- PC: isocoria, RFM +/+, CV conservado a la amenaza, OCM logra excursión horizontal y vertical completa desconjuga sacadas, impresiona nistagmus vertical, corneales simétricos, PFC derecha. Resto no evaluable.
- Motor: Hemiparesia derecha braquial M3, crural M4. Moviliza HC izquierdo al menos M4+. ROT normales. Plantar indiferentes.

- Sensitivo: Sensibilidad algésica impresiona simétrica
- Cerebelo: ataxia axial y apendicular.
- Signos meningeos negativos.

Christian Alejandro Norambuena Aguayo
MEDICO TRATANTE
16447719-3

JEFE SERVICIO